CLÍNICA MUV · PARA MAQUETAR

SEDE TRES CANTOS · FISIOTERAPIA DE RODILLA

*Este documento es **solo para maquetar**: trae el texto exacto que va a la web, los encabezados y las notas de maquetación. Nada más.*

- **URL:** `/sedes/tres-cantos/fisioterapia-rodilla`
- **Encabezados:** 1 H1 + 9 H2 + 21 H3 · 8 preguntas frecuentes. El municipio va en el H1 y en un H2, y en ningún H3. Van tal cual: no se reformulan, no se reordenan y no se les añade el municipio.

Title

`Fisioterapia de rodilla en Tres Cantos: menisco y LCA | MUV`

Meta description

`Menisco, LCA, rótula y tendinitis rotuliana: fisioterapia y rehabilitación de rodilla en Tres Cantos, con o sin operación. Pida cita en MUV.`

> **Estado: borrador.** Lo marcado **en rojo** es un dato que MUV todavía no ha facilitado: **no se maqueta, no se rellena con algo parecido y no se inventa.** Si un bloque depende de un dato rojo, ese bloque espera. La página no se publica en producción hasta que contenidos lo confirme.

> **Versión vigente: 27/10/2026.** Este PDF sustituye al anterior. Solo cambian los textos marcados en **azul**, que se listan aquí debajo; todo lo demás es igual que en la versión publicada.

▲ Qué cambia en esta versión (27/10/2026)

Dónde	Antes	Ahora
Módulo 4 · Ejercicio terapéutico y fuerza · texto	Es la base que recomiendan el consenso sobre el dolor femoropatelar y la guía NICE de artrosis. Se parte de una carga que usted tolere y se sube de forma progresiva.	**Es la base del tratamiento de la rodilla. Se parte de una carga que usted tolere y se sube de forma progresiva.**
Módulo 4 · Neuromodulación percutánea ecoguiada · texto	En la rodilla se utiliza como complemento del ejercicio, cuando la valoración lo indica. Es una técnica reciente y la investigación todavía es limitada.	**En la rodilla se utiliza para aliviar el dolor que persiste, como complemento del ejercicio y cuando la valoración lo indica.**

Si ya hay algo maquetado de esta página, basta con cambiar estas líneas. Cada una aparece también marcada en azul dentro de su módulo.

⚠ Esta página tiene 3 datos pendientes

Módulo	Qué falta
Qué tratamos	**confirmar con el fisioterapeuta que atiende artrosis de rodilla. Mientras no se confirme, este bloque no se publica**
Quién trata su rodilla	**formación del fisioterapeuta, y foto con su permiso**
Dónde estamos y cuándo abrimos	**aparcamiento, accesibilidad de la entrada y transporte**

Todo lo de esta tabla aparece también en rojo dentro de su módulo.

Módulo 1 · Hero

H1

> Fisioterapia de rodilla y lesiones de rodilla en Tres Cantos

Entradilla

> ¿Le duele la rodilla al subir escaleras, al correr o al levantarse de la silla? En MUV Tres Cantos hacemos fisioterapia de rodilla: valoramos su caso, le explicamos qué le pasa y trabajamos con usted hasta que vuelve a confiar en ella. Primero el dolor, después la fuerza y, si es lo que busca, el deporte.

Lo esencial

> - Tratamos dolor femoropatelar, tendinopatías, meniscos, ligamentos —incluido el LCA— y la recuperación tras una operación.
> - El ejercicio y la fuerza son el centro. Las demás técnicas lo complementan.
> - Utilizamos ecografía y, como complemento, neuromodulación ecoguiada, cuando la valoración lo indica.
> - Una sola persona, fisioterapeuta colegiado, le acompaña durante todo el proceso.

Botones

> `[Pedir cita]` · `[Dónde estamos]` *(ancla al módulo 10)*

Módulo 2 · Qué tratamos

Eyebrow: Motivos de consulta

H2

> Lesiones y dolores de rodilla que tratamos en Tres Cantos

Entradilla

> Casi nadie llega sabiendo cómo se llama su lesión: llega sabiendo dónde le duele y cuándo.

H3 · Dolor delante de la rodilla: síndrome femoropatelar y condromalacia

> Dolor alrededor o detrás de la rótula al subir escaleras, ponerse en cuclillas, correr o tras un rato sentado. Es muy frecuente, también sin hacer deporte. El consenso internacional de 2018 recomienda empezar por ejercicio de cadera y de rodilla.

H3 · Tendinitis o tendinopatía rotuliana y del cuádriceps

> Dolor justo debajo o encima de la rótula al saltar, correr o hacer sentadillas. El tendón se irrita cuando la carga supera lo que tolera, y mejora enseñándole a tolerar más, poco a poco.

H3 · Menisco

> Los meniscos amortiguan la rodilla. Pueden lesionarse por un giro brusco o por desgaste. Provocan dolor en el interior o el exterior de la rodilla, chasquidos y, a veces, bloqueos. No todas las roturas necesitan operación: lo explicamos más abajo.

H3 · Ligamentos y rotura del ligamento cruzado anterior (LCA)

> El ligamento cruzado anterior se rompe sobre todo en giros y frenadas. Si hay rotura, la decisión de operar la toma usted con su traumatólogo. Lo que depende de la rehabilitación es cómo se recupera la fuerza y cuándo se vuelve al deporte.

H3 · Artrosis y dolor persistente de rodilla

> Dolor y rigidez que empeoran al ponerse en marcha y que duran meses. Para la artrosis, la guía NICE recomienda ofrecer ejercicio terapéutico adaptado a cada persona y plantea considerar sesiones supervisadas. Es normal notar más molestia al empezar: se empieza con poca carga y se sube despacio. `[PENDIENTE MUV: confirmar con el fisioterapeuta que atiende artrosis de rodilla. Mientras no se confirme, este bloque no se publica]`

H3 · Rehabilitación tras una operación de rodilla

> Tras una artroscopia, una cirugía de menisco o una reconstrucción del LCA, la rodilla debe volver a moverse, cargar y confiar. Si le han operado, traiga el informe y las indicaciones de su cirujano: la rehabilitación parte de ahí.

Módulo 3 · Cómo trabajamos

H2

> Rehabilitación de rodilla: de la valoración a la vuelta a la actividad

H3 · 1. Valoramos

> Hablamos de qué le pasa y qué movimientos le duelen. Exploramos la rodilla, la cadera, el tobillo y la fuerza de las piernas, porque el origen no siempre está donde duele. Cuando está indicado, miramos el tendón o la articulación con ecografía.

H3 · 2. Calmamos el dolor

> El objetivo es que la rodilla pueda moverse y cargar. Aquí entran las técnicas guiadas con ecografía, siempre como apoyo del ejercicio.

H3 · 3. Recuperamos fuerza y control

> Es la fase central: cuádriceps, isquiotibiales, glúteo y gemelo, y control del movimiento al aterrizar, girar y frenar. También hay clases de entrenamiento funcional supervisado en Tres Cantos.

H3 · 4. Volvemos a la actividad

> Primero a la vida diaria y, si es su objetivo, al deporte. La vuelta se decide por criterios —dolor controlado, movilidad completa, fuerza y capacidad de soportar la carga— y no solo por una fecha.

Módulo 4 · Técnicas

H2

> Técnicas de fisioterapia que utilizamos para la rodilla

Entradilla

> En la rodilla, el ejercicio es el centro del plan. El resto se suma solo si la valoración lo justifica. Cada técnica se explica entera en la página de fisioterapia deportiva y readaptación.

H3 · Ejercicio terapéutico y fuerza

> **Es la base del tratamiento de la rodilla. Se parte de una carga que usted tolere y se sube de forma progresiva.**

▲ Texto nuevo (27/10/2026). Lo anterior está en la tabla del principio

H3 · Ecografía musculoesquelética

> Enseña al momento el estado del tendón y del líquido de la articulación, y ayuda a colocar con precisión otras técnicas. Complementa las pruebas de su médico; no las reemplaza.

H3 · Neuromodulación percutánea ecoguiada

> **En la rodilla se utiliza para aliviar el dolor que persiste, como complemento del ejercicio y cuando la valoración lo indica.**

▲ **Texto nuevo (27/10/2026).** **Lo anterior está en la tabla del principio**

Módulo 5 · ¿Operación o ejercicio?

H2

> Rotura de menisco: ¿operar o no? Lo que dice la investigación

H3 · Menisco: una comparación entre cirugía y ejercicio

> Un ensayo clínico noruego, publicado en el *BMJ* en 2016, comparó dos opciones en 140 adultos de unos cincuenta años. Todos tenían una rotura de menisco por desgaste y no tenían artrosis evidente. A unos les asignó doce semanas de ejercicio supervisado y a otros, una artroscopia. A los dos años no había diferencias relevantes en la función de la rodilla. El grupo de ejercicio ganó fuerza en el muslo antes, y casi una de cada cinco personas de ese grupo acabó operándose.
>
> No significa que nadie deba operarse. Hay roturas en las que la cirugía puede ser lo mejor, sobre todo las de un giro brusco o las que bloquean la rodilla. La decisión es de su traumatólogo.

H3 · LCA: por qué se vuelve por criterios y no por fechas

> Un estudio de seguimiento siguió a 106 personas que practicaban deportes con giros. Hubo menos nuevas lesiones de rodilla en quienes retrasaban la vuelta hasta los nueve meses desde la operación. Lo mismo ocurrió en quienes volvían con la fuerza del cuádriceps más simétrica entre las dos piernas.

Módulo 6 · Quién trata su rodilla

H2

> Quién trata su rodilla

> MUV Tres Cantos es un **centro sanitario** inscrito en la Comunidad de Madrid (**CS 21018**). Su fisioterapeuta es **José Luis González Coronado**, colegiado nº 15502 y responsable de la clínica. Él valora su rodilla, la trata y trabaja con usted en la rehabilitación. `[PENDIENTE MUV: formación del fisioterapeuta, y foto con su permiso]`

Módulo 7 · Consejos y mitos

Eyebrow: Mientras tanto

H2

> Tres consejos para el dolor de rodilla y tres mitos

H3 · Muévase, pero dosifique

> El reposo prolongado rara vez ayuda. Mueva la rodilla con una carga que tolere y súbala poco a poco.

H3 · Fortalezca muslos y caderas

> Los músculos que sostienen la rodilla son el punto de partida de casi todos los planes.

H3 · Avise si el dolor va a más

> Una molestia leve que desaparece en un día suele ser tolerable. Si crece, le cambia la forma de andar o persiste, consúltenos antes de seguir.

H3 · Mito: «Con una rotura de menisco hay que operarse siempre»

> No siempre: en roturas por desgaste, el ejercicio supervisado dio resultados muy parecidos a la cirugía a los dos años.

H3 · Mito: «El reposo cura el tendón»

> No. En la tendinopatía rotuliana, la estrategia conservadora más estudiada son los programas de carga progresiva, no el reposo.

H3 · Mito: «Una rodillera lo arregla»

> El consenso internacional de 2018 recomienda el ejercicio como base y reconoce incertidumbre sobre los vendajes y las rodilleras.

Módulo 8 · Cuándo consultar antes con su médico

H2

> Dolor de rodilla: cuándo ir antes al médico o a urgencias

Entradilla

> Estas señales no son habituales, pero piden otra puerta de entrada: su médico o urgencias.

> - Hinchazón intensa en pocas horas tras un golpe o un giro.
> - Rodilla bloqueada, que no se estira del todo o que falla al apoyar.
> - Imposibilidad de apoyar la pierna.
> - Enrojecimiento y calor en la rodilla, con fiebre.
> - Dolor nocturno o en reposo que no mejora cambiando de postura.
> - Pantorrilla dolorida, hinchada o caliente.

Módulo 9 · Preguntas frecuentes

Eyebrow: Dudas habituales

H2

> Preguntas frecuentes sobre la fisioterapia de rodilla

¿Qué tipo de fisioterapia se recomienda para el dolor de rodilla?

> Depende de la causa, pero casi siempre el centro es el ejercicio: fuerza de muslos y caderas, control del movimiento y carga progresiva, con otras técnicas de apoyo.

¿Cuántas sesiones de fisioterapia son necesarias para la rodilla?

> Depende de qué le pasa, desde cuándo y de su actividad. Tras la valoración se concreta un plan.

¿Qué ejercicios debo evitar con una rotura de menisco?

> Depende del tipo de rotura. Hasta que la valoremos, evite lo que le provoque dolor intenso, bloqueo o fallos. Por ejemplo, girar sobre la pierna apoyada o ponerse en cuclillas profundas.

¿Cómo se rehabilita el síndrome femoropatelar?

> Con ejercicio: una combinación de cadera y rodilla, con una carga que sube poco a poco. Suele llevar semanas, no días.

¿Cuánto dura la rehabilitación del LCA?

> Depende de si ha habido operación y de cada persona. Se trabaja por criterios, no por fechas, porque volver demasiado pronto se asocia a más nuevas lesiones.

¿Es bueno caminar con una tendinitis rotuliana?

> Moverse suele ayudar más que parar del todo. Conviene dosificar los saltos, las sentadillas profundas y las bajadas. Si el dolor aumenta, consúltenos.

¿Necesito una resonancia de rodilla para empezar?

> No para empezar la valoración. Si ya tiene pruebas de imagen o informes, tráigalos. La ecografía complementa la exploración y no sustituye a las pruebas que indique su médico.

¿Cuándo empiezo la rehabilitación si me han operado?

> Depende de la operación, y lo marca su cirujano. Traiga el informe y sus indicaciones a la primera cita: la rehabilitación parte de ahí.

Módulo 10 · Dónde estamos y cuándo abrimos

H2

> Dónde estamos y cuándo abrimos

Ficha de contacto

> **MUV Tres Cantos** · Av. de Madrid, 19, Loc 5 · 28760 Tres Cantos
>
> **Horario:** de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00; los sábados, de 9:00 a 14:00. Los domingos cerramos.
>
> **Teléfono:** 614 13 14 05
>
> `[PENDIENTE MUV: aparcamiento, accesibilidad de la entrada y transporte]`

Cómo llegar

> Encontrará cómo llegar, el aparcamiento y la accesibilidad en la página de MUV Tres Cantos.

Botón

> `[Pedir cita para valorar su rodilla]`

Enlaces internos del texto

Módulo	Texto del enlace	Destino
Cómo trabajamos	entrenamiento funcional supervisado en Tres Cantos	`/sedes/tres-cantos/entrenamiento-funcional`
Técnicas	fisioterapia deportiva y readaptación	`/sedes/tres-cantos/fisioterapia-deportiva`
Dónde estamos y cuándo abrimos	MUV Tres Cantos	`/sedes/tres-cantos#como-llegar`

Fuentes (pie de la página, en letra pequeña)

1. Collins NJ et al. *2018 Consensus statement on exercise therapy and physical interventions to treat patellofemoral pain.* Br J Sports Med 2018. PMID 29925502.
2. Kise NJ et al. *Exercise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients.* BMJ 2016. PMID 27440192.
3. Logerstedt DS et al. *Knee Pain and Mobility Impairments: Meniscal and Articular Cartilage Lesions, Revision 2018.* JOSPT 2018. PMID 29385940.
4. Malliaras P et al. *Achilles and patellar tendinopathy loading programmes.* Sports Med 2013. PMID 23494258.

5. Grindem H et al. *Simple decision rules can reduce reinjury risk after ACL reconstruction.* Br J Sports Med 2016. PMID 27162233.
6. NICE. *Osteoarthritis in over 16s: diagnosis and management (NG226).*

Datos pendientes de la clínica (lista completa)

Lo que contenidos está pidiendo a los dueños. Mientras no llegue, lo que dependa de ello **no se maqueta ni se rellena**.

Dato	De quién
¿Atiende artrosis de rodilla? Hasta que lo confirme, el bloque de artrosis no se publica	Fisioterapeuta de Tres Cantos
¿Atiende rehabilitación tras una prótesis de rodilla o una sutura de menisco? La competencia las publica y no se escriben sin confirmación	Fisioterapeuta de Tres Cantos
Formación del fisioterapeuta, en rodilla en concreto, y foto con su permiso	Dueño de Tres Cantos
Aparcamiento, accesibilidad y transporte	Dueño de Tres Cantos
Revisión clínica de consejos, mitos y señales de alarma	Fisioterapeuta de la clínica

---

Notas de maquetación

- **Enlazado:** el módulo 4 enlaza a `/sedes/tres-cantos/fisioterapia-deportiva`; el módulo 10 a `/sedes/tres-cantos#como-llegar`. La página de sede debe enlazar a esta con «fisioterapia de rodilla en Tres Cantos» en el ancla.
- **Marcado:** `BreadcrumbList`, `FAQPage` (las 8 preguntas, todas con respuesta publicada) y el servicio con `provider` apuntando al `@id` del `MedicalClinic` de la sede. Nada de `aggregateRating`, nada de `areaServed`.
- **ALT de las imágenes:** pendientes de elegir las fotos de la galería de Tres Cantos. Cada ALT con la entidad y el municipio, sin repetir el del H1.
- **Cita:** el botón abre el selector de sede ya existente.